

11_pflegebericht_schmerzprotokoll.txt

Pflege- und Schmerzprotokoll

Gregor Lütke

geführt von: Teresa Lütke, Ehefrau

Zeitraum: 17.06.2026 bis 23.06.2026

17.06.2026

Morgens Atemnot nach Treppe vom Schlafzimmer ins Erdgeschoss. Pause auf der siebten Stufe. Schmerz rechte Hüfte 6 von 10. Novalgin genommen. Spaziergang zur Ecke nach 80 Metern abgebrochen.

18.06.2026

Nachts zweimal aufgewacht wegen Druck im Brustkorb. Kein Fieber. Appetit gering. Telefonat mit Klinik: Bitte Schmerzprotokoll weiterführen. Gregor sagt, er wolle die Entscheidung der Kasse nicht "aussitzen", weil er merkt, dass die Luft schlechter wird.

19.06.2026

Hausarzt Dr. Kannenberg daheim. Sauerstoffsättigung nach Gang durch Flur 91 Prozent, in Ruhe 95 Prozent. Oxycodon niedrig dosiert besprochen, Gregor zögert wegen Müdigkeit. Arzt sagt, Therapiefenster solle nicht ohne medizinischen Grund verstreichen.

20.06.2026

Besuch der Schwester. Gregor konnte 35 Minuten am Tisch sitzen, danach Liegen. Schmerz Becken 7 von 10. Einmal Übelkeit. Keine Einweisung, weil Termin in Münster erwartet wird.

21.06.2026

Vormittags besser. 120 Meter bis zum Parkplatz geschafft, aber Rückweg mit zwei Pausen. Abends wieder Atemnot. Gregor fragt nach Patientenverfügung, sagt aber gleichzeitig, er wolle die beantragte Behandlung versuchen.

22.06.2026

Brief der Kasse erneut gelesen. Gregor sehr angespannt. Kein Spaziergang. Schmerzmittel nach Plan, zusätzlich Wärmekissen. Telefonat mit Sozialdienst: Eilantrag soll vorbereitet werden.

23.06.2026

E-Mail der Klinik mit Termin 01.07.2026 erhalten. Gregor erleichtert, zugleich Sorge wegen Kosten. Schmerz rechte Hüfte 5 bis 8 von 10 über den Tag. Atemnot beim Duschen. Teresa organisiert Duschhocker.

10_email_klinik_soforttermin.eml

Von	"Prof. Dr. Mira Ebbinghaus" <onkologie@ukm.de>
An	Gregor Luetke <gregor.luetke@privatpost.de>
Kopie	Sozialdienst UKM <sozialdienst@ukm.de>
Datum	Tue, 23 Jun 2026 16:28:52 +0200
Betreff	Termin 01.07.2026 und Unterlagen zur beantragten Therapie

Sehr geehrter Herr Lütke,

wir haben für Sie am 01.07.2026 um 08:15 Uhr einen Termin in der onkologischen Tagesklinik reserviert. Der Termin dient zunächst der klinischen Untersuchung, Laborabnahme und Aufklärung. Die Gabe von Lunazimerab kann an diesem Tag nur erfolgen, wenn bis dahin eine belastbare Kostenklärung vorliegt.

Medizinisch ist das Zeitfenster eng. Die Bildgebung vom 10.06.2026 zeigt eine zunehmende Belastung der rechten Lunge und eine neue Läsion am Beckenkamm. Ihre Atemnot bei Belastung und die Schmerzspitzen passen dazu. Wir sehen keine kurative Situation. Ziel ist Krankheitskontrolle und Erhalt der Gehstrecke. Das Tumorboard hat wegen Ihrer bisherigen Therapien und der seltenen Tumorbilogie die beantragte Behandlung empfohlen.

Bitte bringen Sie mit:

- aktuellen Medikamentenplan,
- Schmerzprotokoll der letzten sieben Tage,
- Entlassungsbrief der Strahlentherapie aus April 2026,
- Bescheid der Krankenkasse und Schreiben des Medizinischen Dienstes,
- Kontaktdaten einer Vertrauensperson für die Aufklärung.

Wenn die Finanzierung bis 01.07.2026 offen bleibt, müssen wir den Termin in einen Beratungstermin umwandeln. Wir dokumentieren dann, dass die Behandlung nicht aus medizinischen, sondern aus Kostenklärungsgründen nicht begonnen wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Mira Ebbinghaus
Oberärztin Sarkomzentrum
Klinik für Hämatologie und Onkologie
Universitätsklinikum Münster

07_therapie_kostenmatrix.csv

dosis	geplanter_tag	kosten_arznei	kosten_überwachung	klinisches_ziel	streitpunkt
1	2026-07-11	500000.00	18200.00	initiale Krankheit skontrolle	Eilbedürftigkeit und Kosten
2	2026-08-22	500000.00	16400.00	Stabilisierung pulmonaler Herde	Nutzenprognose unsicher
3	2026-10-03	500000.00	16400.00	Verlängerung progressionsfreie Zeit	Folgenabwägung gegen Wirtschaftlichkeit

Antrag der Universitätsklinik Münster

Universitätsklinikum Münster
Klinik für Hämatologie und Onkologie, Sarkomzentrum
Albert-Schweitzer-Campus 1, 48149 Münster
Telefon 0251 83-4 77 51

Prof. Dr. med. Mira Ebbinghaus, Oberärztin Sarkomzentrum
Münster, den 04.06.2026

An die
Vitalis BKK
Leistungszentrum Arzneimittel
Rheinlanddamm 199
44139 Dortmund

Antrag auf Kostenübernahme für Lunazimerab; Versicherter Gregor Lütke, geboren am 22.11.1979,
Versichertennummer V-338-529-114

Antrag auf Kostenübernahme

Für unseren Patienten Gregor Lütke beantragen wir die Kostenübernahme für eine Therapie mit Lunazimerab. Es handelt sich um ein Arzneimittel mit Zulassung für eine seltene Tumorentität. Der Patient leidet an einem metastasierten alveolären Weichteilsarkom mit Progress nach zwei systemischen Vortherapien.

Bisheriger Verlauf

Datum	Maßnahme	Ergebnis
03.02.2022	Tumorresektion linker Oberschenkel	R1-Situation, Nachbestrahlung
04.2022 bis 06.2022	Strahlentherapie	lokale Kontrolle
08.2023	Lungenmetastasen	systemische Therapie begonnen
09.2023 bis 02.2025	Standardtherapie A	zunächst Stabilisierung, dann Progress
03.2025 bis 03.2026	Standardtherapie B	Progress in Lunge und Becken
29.05.2026	Tumorboard	Empfehlung Lunazimerab

Ärztliche Bewertung

Aus onkologischer Sicht besteht eine lebensbedrohliche Erkrankung mit kurzfristig relevanter Progressionsgefahr. Weitere leitliniengerechte Standardoptionen mit vergleichbarer Erfolgsaussicht stehen nicht zur Verfügung. Best Supportive Care ist möglich, würde aber voraussichtlich nur Symptomkontrolle, nicht Krankheitskontrolle erreichen.

Die vorliegenden Daten zu Lunazimerab zeigen bei einer Teilgruppe der Patienten mit vergleichbarer molekularer Signatur relevante Remissionen und eine Verlängerung des progressionsfreien Überlebens. Beim Patienten liegt die Zielstruktur LZ-4 nach immunhistochemischer Untersuchung hoch exprimiert vor.

Wir bitten wegen des geplanten Therapiebeginns am 11.07.2026 um Entscheidung bis zum 05.07.2026; der Hersteller reserviert die erste Dosis nur bis zu diesem Tag. Den Kostenvoranschlag unserer Klinikapotheke reichen wir nach, sobald er vorliegt.

Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. med. Mira Ebbinghaus
Oberärztin Sarkomzentrum

Patient	Gregor Lütke, geboren am 22. November 1979
Sitzung	29. Mai 2026, 07:30 Uhr
Protokoll	TB-SAR-2026-221

Protokoll des interdisziplinären Sarkom-Tumorboards

Teilnehmende: Prof. Dr. Mira Ebbinghaus, Medizinische Onkologie; Prof. Dr. Thilo Varnhagen, Radiologie; Dr. Rike Senf, Pathologie; Dr. Amir Bektas, Strahlentherapie; Apothekerin Nora Grothe.

Ausgangslage: metastasiertes Weichteilsarkom mit Progression unter den dokumentierten Standardtherapien. Bildgebung vom 22. Mai zeigt Zunahme pulmonaler Läsionen und eine neue Läsion am Beckenkamm. Weitere zugelassene systemische Optionen wurden wegen Vorbehandlung und Toxizität als nicht tragfähig bewertet.

Der molekulare Befund weist eine hohe LZ-4-Expression aus. Für Telvuranib-L liegen nicht vergleichende Daten einer kleinen Subgruppe vor. Eine kurative Wirkung ist nicht zu erwarten; diskutiert wurde eine mögliche Krankheitskontrolle bei engmaschiger Bildgebung und Abbruch bei fehlendem Ansprechen.

Beschluss: Empfehlung eines individuellen Therapieversuchs für zwei Zyklen nach Aufklärung und Kostenfreigabe. Vor Beginn sind Blutbild, Leberwerte, EKG und erneute Bildgebung zu erheben. Bewertung nach sechs Wochen; Abbruch bei Progression oder nicht beherrschbarer Toxizität.

Die Empfehlung ist eine medizinische Einzelfallentscheidung und keine Zusage der Kostenübernahme. Prof. Dr. Ebbinghaus erstellt eine gesonderte Nutzen-Risiko-Stellungnahme für den Kostenträger.

Prof. Dr. Mira Ebbinghaus

Leitung Sarkomzentrum

Dr. Rike Senf, Protokollfreigabe

Patient	Gregor Lütke
Wirkstoff	Telvuranib-L
Datum	2. Juni 2026

Ärztliche Nutzen-Risiko-Stellungnahme

Herr Lütke leidet an einem fortschreitenden metastasierten Weichteilsarkom. Die dokumentierten zugelassenen Therapieoptionen sind ausgeschöpft oder wegen vorausgegangener Toxizität nicht mehr vertretbar. Ohne wirksame systemische Behandlung ist kurzfristig mit weiterer pulmonaler und ossärer Progression zu rechnen.

Die Nutzenannahme stützt sich auf die beim Patienten nachgewiesene hohe LZ-4-Expression, präklinische Daten und eine kleine klinische Subgruppe. Die Evidenz ist begrenzt; eine sichere Verlängerung der Lebenszeit lässt sich nicht versprechen. Medizinisches Ziel ist eine zeitlich relevante Krankheitskontrolle bei erhaltener häuslicher Versorgung.

Vorgesehen sind zunächst drei Dosen im Abstand von drei Wochen. Vor jeder Gabe erfolgen Labor, EKG und klinische Untersuchung. Nach zwei Zyklen wird per CT bewertet. Bei Progression, schwerer Organnebenwirkung oder fehlender Belastbarkeit wird die Therapie beendet.

Alternativen sind symptomorientierte Behandlung und die Prüfung einer Studie in Hamburg. Die Studie erfordert nach aktuellem Stand wiederholte Reisen; die Reisefähigkeit ist wegen Sauerstoffbedarf und Schmerzsymptomatik fraglich. Eine endgültige Eignungsprüfung durch das Studienzentrum steht aus.

Der Therapiebeginn ist für 11. Juli 2026 reserviert. Die erste Dosis muss nach Mitteilung der Apotheke bis 5. Juli verbindlich bestellt werden.

Prof. Dr. med. Mira Ebbinghaus

Leitende Oberärztin · Medizinische Onkologie

Stellungnahme des Medizinischen Dienstes

Medizinischer Dienst Westfalen-Lippe

Gutachtenzentrum Münster

Roddestraße 12, 48153 Münster

Gutachter: Dr. med. Peter Niermann, Facharzt für Innere Medizin, Sozialmedizin

Vorgangsnummer: MD-WL-MS-2026-58207

Gutachtliche Stellungnahme nach Aktenlage vom 17.06.2026

Auftrag

Auftrag der Vitalis BKK vom 09.06.2026: Prüfung der beantragten Kostenübernahme für Lunazimerab bei metastasiertem alveolärem Weichteilsarkom; Versicherter Gregor Lütke, geboren am 22.11.1979.

Vorliegende Unterlagen

Antrag der Universitätsklinik Münster vom 04.06.2026 mit Verlaufstabelle, Tumorboardprotokoll vom 29.05.2026, Nutzenblatt der Klinik, immunhistochemischer Befund zur Zielstruktur LZ-4, Publikationsliste zur Studie LUNA-SAR-02. Eine persönliche Untersuchung des Versicherten fand nicht statt.

Zusammenfassung

Beim Versicherten liegt eine schwerwiegende onkologische Erkrankung vor. Die bisherigen leitliniengerechten Therapien sind ausgeschöpft. Gleichwohl kann die beantragte Arzneimitteltherapie aus sozialmedizinischer Sicht nicht empfohlen werden.

Begründung

Die vorgelegten Unterlagen belegen eine Orphan-Drug-Zulassung für eine andere Tumorentität, aber keine abgeschlossene Nutzenbewertung mit tragfähiger Aussage zur zweckmäßigen Vergleichstherapie für die hier vorliegende Erkrankung. Die Klinik verweist auf Phase-II-Daten und Registerdaten. Diese Daten sind hypothesengenerierend und erlauben keine belastbare Aussage, dass beim Versicherten eine Verlängerung der krankheitskontrollierten Zeit um 18 bis 24 Monate zu erwarten ist. Die Subgruppe mit hoher LZ-4-Expression umfasst in der Studie zwölf Patienten.

Best Supportive Care ist möglich; eine Studienteilnahme (Phase-I-Studie in Hamburg, Einschluss nach den Unterlagen frühestens im September) ist nicht ausgeschlossen. Die Kosten von etwa 500.000 EUR je Dosis stehen in einem besonders auffälligen Verhältnis zur unsicheren Nutzenlage. Eine Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung kann aus den vorgelegten Unterlagen nicht abgeleitet werden.

Empfehlung

Ablehnung der Kostenübernahme. Es sollte eine erneute Vorstellung in einer Studienambulanz geprüft werden. Eine palliativmedizinische Mitbehandlung wird empfohlen. Bei wesentlich veränderter Studienlage wird um erneute Vorlage gebeten.

gez. Dr. Niermann

Versichertennummer	V-338-529-114
Aktenzeichen	LZ-AM-2026-07731
Datum	21. Juni 2026

Herrn Gregor Lütke
Zum Häpper 9
48165 Münster

Ablehnung der beantragten Arzneimittelversorgung

Sehr geehrter Herr Lütke,

Ihren Antrag auf Versorgung mit Lunazimerab nach dem Behandlungsplan der Universitätsklinik Münster lehnen wir ab.

Die beantragte Therapie ist für die konkrete Erkrankung nicht regelhaft zugelassen und außergewöhnlich kostenintensiv. Nach der beigefügten Stellungnahme des Medizinischen Dienstes vom 17. Juni 2026 ist die Datenlage nicht hinreichend gesichert. Die vorhandenen Studien sind klein und nicht vergleichend angelegt.

Wir verkennen die Schwere Ihrer Erkrankung nicht. Nach Aktenlage stehen symptomorientierte Behandlung und die Prüfung einer Studienteilnahme weiterhin zur Verfügung. Eine konkrete Zusage des Studienzentrums liegt uns nicht vor.

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch kann schriftlich, elektronisch mit zugelassener Form oder zur Niederschrift bei der Vitalis BKK eingelegt werden.

Anlage: Stellungnahme des Medizinischen Dienstes vom 17. Juni 2026. Sachbearbeitung: Helena König, Durchwahl -448.

Helena König

Leistungszentrum Arzneimittel
Maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig

Datum	25. Juni 2026
Zeit	09:12 bis 09:26 Uhr
Unser Zeichen	2026-233-LÜ/mö

Telefonnotiz der Ehefrau zum Gespräch mit der Krankenkasse

Frau Teresa Lütke berichtete, den Ablehnungsbescheid am 24. Juni im Hausbriefkasten gefunden zu haben. Der Umschlag trägt keinen lesbaren Zustellvermerk; sie hat ihn aufbewahrt und fotografiert.

Am 25. Juni rief sie um 08:31 Uhr beim Leistungszentrum Arzneimittel an. Nach acht Minuten Warteschleife sprach sie mit einer Frau, deren Namen sie als König verstanden habe. Die Sachbearbeiterin habe auf die MD-Stellungnahme verwiesen und sinngemäß gesagt, bei solchen Summen entscheide am Ende häufig ein Gericht.

Frau Lütke fragte nach einer vorläufigen Zusage für die erste Dosis und dem reservierten Termin am 11. Juli. Eine Zusage wurde nicht erteilt. Sie wurde auf den schriftlichen Widerspruch verwiesen. Die Gesprächsdauer im Telefonprotokoll ihres Mobiltelefons beträgt 11 Minuten 42 Sekunden.

Die Mandantin schrieb den Wortlaut unmittelbar danach auf einen Notizzettel. Originalnotiz und Bildschirmfoto der Anrufliste werden als Anlagen T-1 und T-2 verwahrt. Eine Aufzeichnung des Gesprächs existiert nicht.

Dr. Jonas Möllenkamp

Rechtsanwalt · Fachanwalt für Sozialrecht

Unser Zeichen	2026-233-LÜ/mö
Ihr Zeichen	LZ-AM-2026-07731
Datum	29. Juni 2026

An die
Vitalis BKK
Leistungszentrum Arzneimittel
Rheinlanddamm 199
44139 Dortmund

Widerspruch gegen den Bescheid vom 21. Juni 2026

In Sachen Gregor Lütke, geboren am 22.11.1979, Versichertennummer V-338-529-114

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen die Vertretung von Herrn Gregor Lütke an; Vollmacht liegt bei. Namens und in Vollmacht unseres Mandanten legen wir gegen Ihren Bescheid vom 21.06.2026, zugegangen am 24.06.2026, Widerspruch ein.

Die Ablehnung würdigt die konkrete medizinische Situation nicht ausreichend. Unser Mandant leidet an einer lebensbedrohlichen, seltenen Tumorerkrankung. Die leitliniengerechten Standardtherapien sind ausgeschöpft; das ergibt sich aus dem Antrag der Universitätsklinik und wird auch vom Medizinischen Dienst nicht in Zweifel gezogen. Die behandelnde Universitätsklinik hat mit der hohen LZ-4-Expression eine individuelle Zielstruktur nachgewiesen und die Therapie im interdisziplinären Tumorboard empfohlen.

Die Stellungnahme des Medizinischen Dienstes vom 17.06.2026 beruht allein auf der Aktenlage. Sie setzt sich mit dem molekularen Befund nicht auseinander, bewertet die tatsächliche Reisefähigkeit unseres Mandanten für die als Alternative genannte Studie in Hamburg nicht und verhält sich nicht zu dem konkreten Zeitfenster des auf den 11.07.2026 reservierten Therapiebeginns. Der Verweis auf Best Supportive Care bleibt abstrakt: Es wird nicht dargelegt, welche Lebenszeit und Lebensqualität damit realistischerweise erreichbar wären. Eine persönliche Begutachtung hat nicht stattgefunden.

Wir beantragen, den Bescheid vom 21.06.2026 aufzuheben und die Versorgung mit Lunazimerab nach dem Behandlungsplan der Universitätsklinik Münster zu bewilligen, hilfsweise unverzüglich eine persönliche fachonkologische Begutachtung zu veranlassen. Angesichts des Therapiefensters bitten wir um Entscheidung bis zum 03.07.2026; danach werden wir einstweiligen Rechtsschutz in Anspruch nehmen.

Dr. Jonas Möllenkamp

Rechtsanwalt

Anlagen: Vollmacht; Tumorboardprotokoll; Nutzen-Risiko-Stellungnahme; molekularpathologischer Befund; Terminbestätigung der Krankenhausapotheke.

Der Widerspruch wurde am 29. Juni 2026 um 14:18 Uhr per Telefax übermittelt. Sendebericht: sieben Seiten, Status OK. Das Original ging am selben Tag mit Einwurf-Einschreiben zur Post.

Dr. Jonas Möllenkamp

Rechtsanwalt · Fachanwalt für Sozialrecht und Medizinrecht

Antragsteller	Gregor Lütke
Antragsgegnerin	Vitalis BKK
Entwurf	30. Juni 2026

An das Sozialgericht Münster
Alter Steinweg 45
48143 Münster

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

Entwurf Eilantrag Sozialgericht Münster

Entwurf vom 30.06.2026, Az. 2026-233-LÜ/mö — Einreichung per beA, sobald die Kasse nicht bis zum 03.07.2026 abhilft

Antrag:

Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, dem Antragsteller vorläufig die Versorgung mit Lunazimerab nach ärztlicher Verordnung der Universitätsklinik Münster für zunächst drei Dosen zu gewähren.

Hilfsweise wird beantragt, die Antragsgegnerin zu verpflichten, binnen 48 Stunden eine persönliche fachonkologische Begutachtung unter Einbeziehung des Tumorboards zu veranlassen und bis dahin die Therapiereservierung nicht durch Untätigkeit vereiteln zu lassen.

Anordnungsgrund

Der Therapieslot ist auf den 11.07.2026 reserviert; der Hersteller hält die erste Dosis nur bis zum 05.07.2026 vor, danach ist eine neue Freigabe mit Lieferzeit erforderlich. Nach Auskunft der Klinik verschlechtert jede weitere Verzögerung die Chance auf Krankheitskontrolle; die Bildgebung vom 10.06.2026 zeigt eine zunehmende Belastung der rechten Lunge und eine neue Läsion am Beckenkamm. Eine Entscheidung in der Hauptsache käme für den Antragsteller voraussichtlich zu spät. Die Eheleute Lütke können Kosten von rund 500.000 EUR je Dosis offensichtlich nicht vorfinanzieren.

Beweisangebote

Ärztliche Stellungnahme Prof. Dr. Ebbinghaus.

Tumorboardprotokoll vom 29.05.2026.

Molekularpathologischer Befund LZ-4.

Kostenvoranschlag der Krankenhausapotheke vom 21.06.2026.

Anhörung der behandelnden Onkologin.

Hilfsweise gerichtliches Sachverständigengutachten mit Fristsetzung.

Sachverhalt

Der Antragsteller leidet an einem rasch progredienten metastasierten Sarkom. Der Therapietermin ist für 11. Juli reserviert; die erste Dosis muss nach Mitteilung der Krankenhausapotheke bis 5. Juli verbindlich bestellt werden. Der Widerspruch vom 29. Juni ist bislang nicht beschieden.

Glaubhaftmachung

Die medizinische Dringlichkeit wird durch eidesstattliche Versicherung des Antragstellers, Tumorboardprotokoll, Nutzen-Risiko-Stellungnahme und Terminbestätigung glaubhaft gemacht. Die begrenzte Evidenz wird offengelegt; Gegenstand des Eilverfahrens ist die vorläufige Versorgung unter engmaschiger Kontrolle.

**Anlagenverzeichnis: A1 Vollmacht; A2 Bescheid; A3 Widerspruch; A4 Tumorboardprotokoll;
A5 Nutzen-Risiko-Stellungnahme; A6 Molekularbefund; A7 Kostenvoranschlag; A8
Terminbestätigung; A9 eidesstattliche Versicherung.**

Dr. Jonas Möllenkamp

Rechtsanwalt · Fachanwalt für Sozialrecht und Medizinrecht

Möllenkamp & Feldhaus Rechtsanwälte

Windthorststraße 16, 48143 Münster · Rechtsanwalt Dr. Jonas Möllenkamp

Unser Zeichen: 2026-233-LÜ/mö · Stand: 30. Juni 2026

Beweisfragen und Vergleichsfenster im Eilverfahren

Betreff: Gregor Lütke ./ Vitalis BKK wegen Kostenübernahme Telvuranib-L.

Dieses Arbeitspapier dient der Vorbereitung eines sozialgerichtlichen Eilverfahrens. Es ordnet die Fragen so, dass Klinik, Kasse und Gericht nicht aneinander vorbeiprüfen.

Medizinische Beweisfragen

Erstens ist zu klären, ob die Standardtherapien tatsächlich ausgeschöpft oder kontraindiziert sind. Zweitens ist zu beantworten, ob für Telvuranib-L im konkreten molekularen Profil eine nicht ganz fernliegende Aussicht auf spürbaren Nutzen besteht. Drittens muss die zeitliche Dringlichkeit aus Progress, Allgemeinzustand und Behandlungsfenster hergeleitet werden.

Rechtliche Beweisfragen

Das Gericht wird voraussichtlich nach Schwere der Erkrankung, Alternativlosigkeit, Datenlage, Risikoabwägung und Folgenabwägung fragen. Die Antragsbegründung sollte deshalb nicht nur Kosten und Wunschtherapie betonen, sondern den konkreten medizinischen Entscheidungspfad des Tumorboards nachvollziehbar machen.

Vergleichsfenster

Denkbar ist eine Kostenübernahme für zwei Zyklen mit vorher festgelegten Abbruchkriterien, Verlaufsbildgebung und erneuter Entscheidung nach Tumorboard. Diese Linie erhält der Kasse Kontrolle, verhindert aber den irreversiblen Verlust des Behandlungsfensters.

Kostenvoranschlag der Krankenhausapotheker

Universitätsklinikum Münster

Apotheker und Arzneimittelherstellung

Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebäude A12, 48149 Münster

Telefon 0251 83-4 80 20

Vorgang: Gregor Lütke, geboren am 22.11.1979, Fallnummer UKM-2026-448 517

Erstellt am: 21.06.2026, auf Anforderung des Sarkomzentrums (Prof. Dr. Ebbinghaus)

Arzneimittel

Lunazimerab 500 mg Infusionskonzentrat, Sonderbeschaffung über Herstellerprogramm "LZM-Access EU". Das Arzneimittel ist für die beantragte Indikation nicht als Standardtherapie im deutschen Versorgungspfad hinterlegt. Die Klinik sieht nach Tumorboardbeschluss dennoch ein enges Zeitfenster, weil der Patient nach der letzten Bildgebung vom 10.06.2026 eine deutliche Progression in Lunge und Becken zeigt.

Kosten

Position	Menge	Einzelbetrag	Gesamt
Wirkstoff Lunazimerab 500 mg	1 Dosis	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR
Einfuhr, Kühlkette, Sicherheitslogistik	1 Vorgang	8.920,00 EUR	8.920,00 EUR
Sterile Aufbereitung und Plausibilitätsprüfung	1 Vorgang	1.480,00 EUR	1.480,00 EUR
Begleitmedikation und Notfallset	1 Gabe	1.265,00 EUR	1.265,00 EUR
Summe erste Gabe			511.665,00 EUR

Für den beantragten Behandlungszyklus sind drei Gaben im Abstand von jeweils sechs Wochen vorgesehen (geplant 11.07.2026, 22.08.2026 und 03.10.2026). Die Apotheke kalkuliert für drei Gaben einschließlich Logistik und Aufbereitung 1.534.995,00 EUR.

Liefer- und Verfallsrisiko

Der Hersteller reserviert die erste Dosis bis 05.07.2026. Danach ist eine neue Freigabe erforderlich. Eine angebrochene Dosis kann nicht weiterverwendet werden. Die Lieferung muss 72 Stunden vor Applikation beauftragt sein. Eine Finanzierung nachträglich nach Gabe ist aus Sicht der Apotheke nur möglich, wenn vorher eine Kostenzusage, ein gerichtlicher Beschluss oder eine schriftliche Übernahmeerklärung vorliegt.

Fachliche Rückfrage der Apotheke

Die Apotheke bittet die behandelnde Klinik um schriftliche Bestätigung, ob die erste Gabe ambulant in der Tagesklinik oder stationär erfolgen soll. Bei stationärer Gabe sind gesonderte DRG- und NUB-Fragen zu klären. Bei ambulanter Gabe liegt das Kostenrisiko unmittelbarer bei der beantragten Einzelkostenübernahme.